Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
6ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de Porto Alegre

Rua Manoelito de Ornelas, 50 - Bairro: Praia de Belas - CEP: 90110230 - Fone: (51) 3210-6500 - Balcão virtual (51) 997893836 - Email: frpoacent6vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5122316-62.2023.8.21.0001/RS

AUTOR: MARIA TERESINHA DE SOUZA LENZ

RÉU: UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA

SENTENÇA

MARIA TERESINHA DE SOUZA LENZ ajuizou **ação de obrigação de fazer** contra UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA aludindo ser portadora de doença renal crônica, estágio 5, CID 10 N18.0. Relatou também ser portadora de doenças de base, tais como diabetes mellitus tipo 2, hipertensão arterial sistêmica e sobrepeso/obesidade, estando em tratamento dialítico crônico (hemodiálise) há 5 anos, sendo que há 3 anos aguarda receber um transplante renal. Relatou que as oportunidades de transplante renal que teve até o momento foram contraindicadas em razão da prova cruzada ter testado positivo. Disse que o teste positivo da prova cruzada é decorrente de estar hipersensibilizada imunologicamente contra os antígenos HLA (alo-anticorpos anti-HLA), em função das 3 gestações que teve, bem como pelas transfusões sanguíneas que já recebeu. Relatou que, nos últimos testes realizados, apresentou uma resposta positiva para o tratamento de dessensibilização, a fim de viabilizar o recebimento do transplante. O tratamento de dessensibilização, por sua vez, consiste em ciclos de rituximab, plasmaférese e imunoglobulina humana, com o objetivo de diminuir a quantidade de anticorpos anti-HLA da paciente. Mencionou que o fornecimento da rituximab e da imunoglobulina humana foi negado pelo plano de saúde, com a justificativa de que a prescrição para o tratamento em questão seria experimental (*off-label*). Discorreu sobre o dever de cobertura dos medicamentos prescritos pelo médico. Teceu considerações sobre a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Postulou, em sede de antecipação de tutela, o fornecimento dos medicamentos prescritos para os ciclos dessensibilização: a) 9 sessões de plasmaférese; b) imunoglobulina humana 0,1 mg/kg, com administração após cada sessão de plasmaférese e; c) 2 doses de rituximab 1000 mg. Requereu a concessão da gratuidade judiciária, prioridade na tramitação e procedência dos pedidos (evento 1, INIC1). Juntou documentos.

A gratuidade judiciária foi concedida e a antecipação da tutela foi deferida, bem como determinada a citação (evento 6, DESPADEC1).

A UNIMED apresentou contestação (evento 15, CONT1). Argumentou que não há regulamentação que obrigue os planos de saúde a fornecer medicamentos de caráter *off-label,* como os prescritos à autora. Disse que a indicação dos fármacos que a autora busca a cobertura não se enquadram para o seu caso. Requereu a improcedência da ação. Juntou documentos.

A autora notificou o não cumprimento da decisão liminar (evento 18, PED LIMINAR_ANT TUTE1) e juntou documentos.

Oportunizada vista à parte ré (evento 20, DESPADEC1).

Sobreveio réplica (evento 24, RÉPLICA1).

A UNIMED informou que o tratamento foi autorizado (evento 26, PET1), o que foi impugnado pela autora (evento 27, PED LIMINAR_ANT TUTE1).

A ré foi intimada para comprovar o cumprimento da decisão liminar (evento 28, DESPADEC1 e evento 33, DESPADEC1).

A autora confirmou a realização do primeiro ciclo do tratamento (evento 44, PET1).

Intimadas sobre a produção de provas (evento 46, DESPADEC1), a parte ré postulou o julgamento do feito (evento 50, PET1).

A autora requereu o depoimento pessoal da parte ré (evento 51, PET1), o que foi deferido (evento 53, DESPADEC1).

Em audiência, foi proposta a conciliação, que se mostrou inexitosa. Foi colhido o depoimento pessoal da parte ré. Encerrada a instrução, foi aberto prazo para juntada de razões finais (evento 82, TERMOAUD1), acostadas ao evento 85, MEMORIAIS1 e evento 86, MEMORIAIS1.

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

DECIDO.

Presentes as condições da ação, bem como todos os pressupostos necessários ao desenvolvimento válido e regular do processo e ausência de preliminares, motivo pelo qual inexiste óbice à apreciação do mérito.

A parte autora busca a cobertura completa do tratamento de dessensibilização prescrito pelo médico, com o objetivo de diminuir a quantidade de anticorpos anti-HLA e viabilizar a realização de um transplante renal. A requerente é portadora de doença renal, em tratamento dialítico crônico (hemodiálise) há 5 anos.

Inicialmente, destaca-se que incidem à espécie as disposições do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a situação dos autos se enquadra no disposto pelo seu art. 3º, §2º, devendo, portanto, as cláusulas contratuais respeitarem as regras dispostas na legislação consumerista. Nestes termos, também, a Súmula 608 do STJ: *Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.*

É incontroverso que a autora é beneficiária do plano de assistência à saúde operado pela requerida (evento 1, OUT7), tratando-se de contrato regulamentado pela Lei dos Planos de Saúde (n. 9.656/98). Além disso, o diagnóstico da autora também está demonstrado nos autos, bem como a prescrição médica para o tratamento de dessensibilização, consistente em ciclos de rituximab, plasmaférese e imunoglobulina humana (evento 1, LAUDO10).

A controvérsia reside na legitimidade da negativa de cobertura do tratamento pelo plano de saúde, fundamentado na circunstância de que os medicamentos prescritos não são utilizados para o tratamento de doença renal crônica, tratando-se, portanto, de uso *off-label* (evento 1, OUT11).

Nesse sentido, a prova oral coligida aos autos:

Marcelo Ferreira Bortolini, representante legal da parte ré, disse que a negativa por parte da Unimed se deu em razão do uso *off-label* dos medicamentos. Disse que tem conhecimento da prescrição médica juntada aos autos. Não tem conhecimento sobre as pesquisas clínicas relacionadas aos medicamentos. Disse que não há indicação da ANVISA para o tratamento. Referiu que os medicamentos são registrados na ANVISA para outros propósitos. Não sabe dizer sobre o descumprimento da decisão liminar.

A parte ré não nega haver cobertura no plano de saúde para a patologia que acomete a autora e inexiste no contrato trazido aos autos exclusão expressa quanto ao mal do qual ela padece (evento 15, CONTR2), tampouco há exclusão quanto à cobertura do tratamento prescrito. Além disso, os medicamentos são registrados na ANVISA.

Com efeito, não cabe à operadora de plano de saúde delimitar o tipo de tratamento prescrito pelo médico que acompanha o paciente, mas tão somente estabelecer o tipo de doença que terá cobertura no contrato celebrado entre as partes.

O médico assistente é quem decidirá se a situação concreta de enfermidade do paciente está adequada ao tratamento conforme as indicações de uso daquele específico remédio, tornando inviável que a operadora do plano se negue a cobrir o tratamento sob a justificativa de que a moléstia da segurada não está contida nas indicações de utilização do medicamento, considerando que representaria inegável ingerência na ciência médica, em prejuízo do paciente enfermo.

Nesse contexto, a exclusão de cobertura se mostra abusiva, devendo o plano de saúde fornecer a medicação requerida nos termos do laudo prescrito pelo médico responsável pelo tratamento da autora, porquanto cabe ao profissional médico prescrever qual o melhor tratamento ao seu paciente, não ao plano de saúde.

Outrossim, conforme pesquisa no Sistema E-NATJUS (ferramenta lançada para auxiliar na solução das controvérsias, como apoio ao judiciário, pelo CNJ e o Ministério da Saúde), é possível aferir, nas Notas Técnicas juntadas com a inicial, **a eficácia do tratamento combinado de imunoglobulina humana com rituximabe, para pacientes com doença renal crônica, diante das evidências científicas existentes**, tudo a fim de viabilizar o transplante renal.

Oportunamente, transcrevo fundamentos da Nota Técnica n. 136958 (evento 18, NOTATEC9), de 31/05/2023:

> *[...]*
>
> *Os protocolos de dessensibilização são variados e, via de regra, utilizam imunoglobulina em associação com plasmaférese e imunossupressores como rituximabe e bortezomibe. Há dados na literatura que corroboram bons resultados e boa sobrevida de paciente e enxerto após utilização de estratégias de dessensibilização. Ainda que onerosa, a terapia de dessensibilização utilizando imunoglobulina humana polivalente (IVIg) na dose de 2g/Kg em infusões mensais se mostrou efetiva e segura para proporcionar o transplante renal de pacientes sensibilizados com doador vivo contra o qual apresentavam prova cruzada positiva.*
>
> *[...]*
>
> *Benefício/efeito/resultado esperado da tecnologia: PERMITIR A TRANSPLANTAÇÃO - PADRÃO OURO DO TRATAMENTO DA DOENÇA RENAL CRÔNICA.*
>
> *A combinação de altas doses (2 g/kg por dose) de IVIG e rituximabe demonstrou ser segura e eficaz na redução dos níveis de anticorpos anti-HLA e no aumento das taxas de transplante entre pacientes altamente sensibilizados que aguardam transplante de um doador vivo ou falecido.*
>
> *Conclusão*
>
> *Tecnologia: IMUNOGLOBULINA*
>
> ***Conclusão Justificada: Favorável***
>
> *Conclusão: CONSIDERANDO a condição da parte autora, afirmada nos autos, como portadora de doença renal crônica em estágio final com PRA elevado, sensibilizada contra antígenos HLA e com baixa probabilidade de transplantação; CONSIDERANDO a indubitável necessidade de terapia de dessensibilização para a realização do transplante renal; CONSIDERANDO os dados de superioridade do transplante renal em relação à sobrevida e qualidade de vida quando comparado à terapia dialítica no tratamento da doença renal crônica; CONSIDERANDO os dados da literatura médica que atestam eficácia, segurança e custoefetividade no provimento da transplantabilidade em pacientes hipersensibilizados por meio de terapias de dessensibilização;*

CONCLUO este parecer de forma FAVORÁVEL à administração de imunoglobulina humana** polivalente na dose de 2g/Kg, com infusões mensais, por 4 meses, **com finalidade de terapia de dessensibilização em paciente renal crônica estágio 5 hipersensibilizada.

Há evidências científicas? Sim

Assim, além de corroborar a prescrição por médico assistente, restam preenchidos os requisitos previstos pelo art. 10, §13, incisos I e II, da Lei 9.656/98, o que enseja o reconhecimento do dever de cobertura do procedimento médico pela requerida:

> *Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:*
>
> *§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:*
>
> *I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou **(Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022)***
>
> *II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. **(Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022)***

Portanto, seguindo a linha da jurisprudência do STJ, deve-se reputar abusiva *"a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental"* (AgInt no AREsp 1.653.706/SP, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020; AgInt no AREsp 1.677.613/SP, Terceira Turma, julgado em 28/09/2020, DJe 07/10/2020; AgInt no REsp 1.680.415/CE, Quarta Turma, julgado em 31/08/2020, DJe 11/09/2020; AgInt no AREsp 1.536.948/SP, Quarta Turma, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020).

Sobre o tema, cito a posição mais recente da jurisprudência do STJ:

> *AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER. USO OFF LABEL. RECUSA INDEVIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.*
> *1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).*
> *2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS é irrelevante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução normativa.*
> *Precedentes.*
> ***3. Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental" (AgInt no AREsp n. 1.653.706/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 26/10/2020).***
> *4. Agravo interno a que se nega provimento.*
> *(AgInt no REsp n. 2.046.502/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023) Grifei.*
>
> *AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE REQUERIDA. **1. Segundo a jurisprudência do STJ, é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental, especialmente na hipótese em que se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário.** 2. Agravo interno desprovido." (AgInt no REsp n. 2.016.007/MG, relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). Grifei.*
>
> *AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.*
> *1. No caso sub judice, para acolher a pretensão recursal acerca do alegado cerceamento de defesa seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. Precedentes.*
> *2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, revela-se abusivo o preceito excludente do custeio, pelo plano de saúde, dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clínico ou do procedimento cirúrgico ou de internação hospitalar relativos à doença coberta. **2.1. Igualmente abusiva a exclusão do custeio do tratamento consistente no uso off label de medicamento, o qual era imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário.***
> *Incidência da Súmula 83 do STJ.*
> *3. Agravo interno desprovido.*
> *(AgInt no AREsp n. 2.012.180/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 26/9/2022.) Grifei.,*

No mesmo sentido, o TJRS:

> *APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA CONTRATUAL. MEDICAMENTO DE USO OFF LABEL. REGISTRADO PELA ANVISA. RITUXIMABE. 1**) Revela-se abusiva a negativa de cobertura, pela Operadora do Plano de Saúde, a tratamento com medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico assistente do paciente, ainda que utilizado off label ou em caráter experimental.** Precedentes do STJ e deste Colegiado. 2) Situação em que há indicação do médico assistente da parte autora para o tratamento da patologia "Miastenia gravis" (CID: G70), com o medicamento RITUXIMAB, ensejando a confirmação da sentença que julgou procedente a ação e determinou fosse alcançada a cobertura. Honorários recursais devidos. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. (Apelação Cível, Nº 51545454620218210001, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em: 30-01-2024) Grifei.*

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RETORNO DOS AUTOS DO STJ. NOVO JULGAMENTO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE IMPLANTE DE TRANSCATETER MITRACLIP. ROL DA ANS. NEGATIVA DE COBERTURA. DESCABIMENTO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. I. NO CASO EM TELA, A AUTORA PRETENDE VER RECONHECIDA A OBRIGAÇÃO DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE EM COBRIR OS CUSTOS COM A INTERNAÇÃO HOSPITALAR E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE IMPLANTE DE TRANSCATETER MITRACLIP. POR SUA VEZ, A PARTE RÉ NEGOU COBERTURA AO PROCEDIMENTO AO ARGUMENTO DE QUE NÃO HÁ PREVISÃO NO ROL DA ANS, ADUZINDO SUA TAXATIVIDADE. II. O CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE ESTÁ SUBMETIDO ÀS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NESTAS CIRCUNSTÂNCIAS, O ART. 47, DO CDC, DETERMINA QUE AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS SERÃO INTERPRETADAS DE MANEIRA MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. IGUALMENTE, DEVE INCIDIR O DISPOSTO NO ART. 51, IV, § 1°, II, DO CDC, SEGUNDO O QUAL É NULA A CLÁUSULA QUE ESTABELEÇA OBRIGAÇÕES CONSIDERADAS INÍQUAS, QUE COLOQUEM O CONSUMIDOR EM DESVANTAGEM. III. OS PLANOS DE SAÚDE APENAS PODEM ESTABELECER PARA QUAIS DOENÇAS OFERECERÃO COBERTURA, NÃO LHES CABENDO LIMITAR O TIPO DE TRATAMENTO QUE SERÁ PRESCRITO, INCUMBÊNCIA ESSA QUE PERTENCE AO PROFISSIONAL DA MEDICINA QUE ASSISTE O PACIENTE, AINDA QUE NÃO HAJA PREVISÃO EM ROL DA ANS, O QUAL CONSTITUI APENAS REFERÊNCIA BÁSICA DE COBERTURA, CONFORME § 12 DO ART. 10 DA LEI N° 9.656/98, INCLUÍDO PELA LEI N° 14.454/2022, NÃO SENDO, PORTANTO, TAXATIVO. ***ADEMAIS, DE ACORDO COM O § 13, I, DO ART. 10 DA LEI N° 9.656/98, INCLUÍDO PELA LEI N° 14.454/2022, É POSSÍVEL COBERTURA DE PROCEDIMENTO OU TRATAMENTO QUE NÃO ESTEJA PREVISTO NO ROL DA ANS QUANDO EXISTIR COMPROVAÇÃO DA EFICÁCIA, À LUZ DAS CIÊNCIAS DA SAÚDE, BASEADA EM EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS E PLANO TERAPÊUTICO, OU RECOMENDAÇÃO PELA COMISSÃO NACIONAL DE INCORPORAÇÃO DE TECNOLOGIAS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (CONITEC), OU DE, NO MÍNIMO, 1 (UM) ÓRGÃO DE AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE QUE TENHA RENOME INTERNACIONAL, DESDE QUE SEJAM APROVADAS TAMBÉM PARA SEUS NACIONAIS. IV. NO CASO, HÁ NOTA TÉCNICA DA PLATAFORMA E-NATJUS (NOTA TÉCNICA 77293) FAVORÁVEL À REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO POSTULADO EM PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA MITRAL REUMÁTICA (CID I05.1), COMO NO CASO DA AUTORA.*** *PARA MAIS, A NOTA TÉCNICA SE DÁ NO MESMO SENTIDO DO PARECER Nº 3/12, EMITIDO PELO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, NO PROCESSO-CONSULTA Nº 5.935/11, EM QUE FOI RECONHECIDO O MÉTODO MITRACLIP COMO PRÁTICA MÉDICA INCONTESTE. V. PORTANTO, À LUZ DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DA LEI N° 9.656/98, IMPÕE-SE À OPERADORA DO PLANO SUPORTAR AS DESPESAS DO TRATAMENTO EM QUESTÃO, NA MEDIDA EM QUE SE ENQUADRA NA HIPÓTESE DE EXCEÇÃO PREVISTA PELA LEGISLAÇÃO PARA COBERTURA DO TRATAMENTO. VI. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS, CONSIDERANDO O DECAIMENTO INTEGRAL DA PARTE RÉ EM SUAS PRETENSÕES. APELAÇÃO PROVIDA.(Apelação Cível, Nº 50157729720218210008, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 29-11-2023) Grifei.*

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AUTORA GESTANTE DIAGNOSTICADA COM SÍNDROME ANTI-FOSFOLÍPIDE. GESTAÇÃO DE ALTO RISCO. PRESCRIÇÃO DE IMUNOGLOBULINA HUMANA 15G. ***O FATO DE A MEDICAÇÃO SER "OFF LABEL", OU SEJA, EMPREGADA PARA USO CUJA INDICAÇÃO NÃO ESTÁ NA BULA, NÃO CONSTITUI ÓBICE AO SEU FORNECIMENTO PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. EM CONSULTA AO SISTEMA E-NATJUS, FERRAMENTA LANÇADA PARA AUXILIAR NA SOLUÇÃO DAS CONTROVÉRSIAS, COMO APOIO AO JUDICIÁRIO, PELO CNJ E O MINISTÉRIO DA SAÚDE, FOI POSSÍVEL CONCLUIR PELA EXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFICÁCIA BASEADA EM EVIDÊNCIAS CIENTIFICAS DA UTILIZAÇÃO IMUNOGLOBULINA HUMANA POR PACIENTES, ASSIM COMO A AUTORA,*** *DIAGNOSTICADOS COM SÍNDROME ANTI-FOSFOLÍPIDE, CID O 99.1 COMO MEIO DE PREVENIR ABORTAMENTO. NOTA TÉCNICA 101650 PRODUZIDA EM CASO SEMELHANTE AO CASO DOS AUTOS COM CONCLUSÃO FAVORÁVEL À UTILIZAÇÃO DO MEDICAMENTO. DEVER DE COBERTURA RECONHECIDO. . DANO MORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. A OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE NÃO PRATICA ATO ILÍCITO GERADOR DE DANO MORAL, POR SI SÓ, AO NEGAR A COBERTURA DE DETERMINADO PROCEDIMENTO, BASEADA EM CLÁUSULA, SEGUNDO SUA INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL. A EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL NA INTERPRETAÇÃO DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE AFASTA A CARACTERIZAÇÃO DE CONDUTA ILÍCITA CAPAZ DE ENSEJAR INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível, Nº 50005109120198210036, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 15-12-2022) Grifei.*

Portanto, impõe-se à operadora do plano suportar as despesas do tratamento em questão, na medida em que se enquadra na hipótese prevista pela legislação para cobertura do tratamento.

Por fim, quanto às astreintes outrora fixadas, considerando que, da análise dos autos, a autorização era controvertida, e tendo em vista o despacho do evento 33, DESPADEC1, a demandada tinha o prazo de 5 dias, contados da sua intimação pessoal, em 15/09/2023, para comprovar o fornecimento da medicação, o que foi observado, já que o documento acostado ao evento 39, PET1 demonstra a realização do primeiro ciclo ainda em 07/09/2023. Logo, não há falar em consolidação da multa.

Diante do exposto, na forma do art. 487, I, do CPC, **JULGO PROCEDENTES** os pedidos veiculados na ação ajuizada por MARIA TERESINHA DE SOUZA LENZ para **CONDENAR** a UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MÉDICA LTDA à cobertura de **9 doses de imunoglobulina humana 0,1 mg/kg para administração após cada sessão de plasmaférese, bem como 2 doses de Rituximab 1000 mg**, com aplicação em ambiente hospitalar e/ou ambulatorial da própria requerida ou de sua rede conveniada, conforme indicação médica, ratificando a tutela de urgência outrora deferida (evento 6, DESPADEC1).

Condeno a parte ré ao pagamento da Taxa Única de Serviços Judiciais e despesas processuais, bem como honorários de advogado da parte adversa, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, corrigido monetariamente pelo IPCA desde o ajuizamento da ação (Súmula 14 do STJ), acrescido de juros de mora desde o trânsito em julgado, observados o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, §2º, do CPC).

Tendo em vista a sistemática do Código de Processo Civil e, diante da inexistência de juízo de admissibilidade, conforme dispõe o art. 1.010, §3º, do CPC, em caso de interposição de recurso de apelação, proceda-se à intimação da parte apelada para apresentar contrarrazões, querendo, no prazo de 15 dias. Decorrido o prazo, subam os autos ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.

Com o trânsito em julgado, nada requerido no prazo de 5 dias, e satisfeitas eventuais custas pendentes, baixe-se.

Caso não seja efetuado o pagamento das custas, oficie-se ao TJRS, a fim de informar o não pagamento, nos termos do Ato n. 072/2022 - P.

Sentença publicada e registrada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por **DEISE FABIANA LANGE VICENTE, Juíza de Direito**, em 30/10/2024, às 19:30:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10070856536v14** e o código CRC **41c0c7d8**.